

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	膽結石				
	Gall Bladder Stone ; GB Stone				
編號	A31000-Q03-W-D03	制定者	N11 莊淑娟	公布日期	97 年 11 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.8 版/10 頁	審查者	曾翊捷	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解膽結石的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

膽結石是膽道(biliary duct)中最常見的一種疾病，形成的原因包含膽汁的水分過度吸收、膽汁的膽酸過度吸收、膽汁內膽固醇過多及膽道上皮發炎。膽結石通常好發於膽囊中，也可存在於膽道系統中的任何部位，依結石存在位置不同可分成三類：在膽囊內叫膽囊結石、在總膽管內叫總膽管結石、在肝內膽管叫肝內結石。

（二）危險因子

女性、肥胖、懷孕、糖尿病、高熱量飲食、高碳水化合物飲食、低纖維飲食、靜態生活、高三酸甘油脂血症、賀爾蒙因素包括懷孕、口服避孕藥、使用女性荷爾蒙治療等。

（三）症狀

病人在進食多量油炸或脂肪性食物後 3~6 小時發生上腹部絞痛。右上象限脹痛，疼痛會放射至右肩膀或肩胛處。觸診時出現摩菲氏徵象(Murphy's sign)（指觸壓右上腹部的肋下緣時，若要求受檢者深呼吸或咳嗽會引發疼痛）。總膽管阻

主題名稱	膽結石	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D03	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/10

塞時會出現噁心、嘔吐、心灼熱感、發燒、寒顫、盜汗、黃疸、尿液顏色變深、灰白色便等症狀。

(四) 常見檢查

1. 腹部超音波(Abdominal echo)。
2. 經皮穿肝膽道攝影術(Percutaneous Transhepatic Cholangiography；PTC)。
3. 經內視鏡逆行性膽胰攝影術(Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography；ERCP)。
4. 口服膽囊攝影(Oral cholecystogram；OC)。
5. 血液檢查：白血球數增多。肝功能：SGOT、SGPT、LDH、鹼性磷酸酶值均升高、血清膽紅素和尿膽素原升高。

(五) 常見治療

1. 藥物治療：

(1)止痛劑：Demerol。

作用：止痛。

副作用：低血壓、便秘。

(2)抗膽鹼激素性藥物：Atropine。

作用：用以預防膽道平滑肌收縮。

副作用：口乾、散瞳。

(3)抗痙攣劑：Pro-Banthine。

作用：用以消除平滑肌痙攣情況。

副作用：便秘、排尿困難。

(4)止吐劑：治療噁心嘔吐。

(5)抗生素：控制感染。

(6)膽鹽：如 Decholan, Zanchol。

作用：可促進脂肪和脂溶性維生素的吸收。

(7)脂溶性維生素，如 A、D、E、K。

主題名稱	膽結石	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D03	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/10

(8)Questran：

作用：可結合腸道中的膽鹽，形成不溶性化合物，由糞便排出，以排出過多的膽鹽和減輕搔癢。

副作用：便秘。

(9)CDCA(Chenodexocholic Acid)或 UDCA(Ursodeoxycholic Acid)：

作用：是一種化學性溶劑，藉此服用降低膽汁中膽固醇的飽和度，來溶解膽囊中的結石。

(10)Buwecon：

作用：抑制副交感神經，鎮痙、鎮痛。

副作用：口渴、便秘。

(11)Buscopan：

作用：解除胃腸痙攣。

副作用：口渴、便秘。

(12)Cospanon：

作用：促進膽汁的排泄、鬆弛歐狄氏括約肌、解痙。

副作用：食慾不振、眩暈。

2. 飲食治療：

治療膽結石首重飲食的控制，水果皆可食用，蔬菜則以深綠色為佳，但會脹氣的蔬菜則不宜，如洋蔥、韭菜、豆類等。平時應減少脂肪的攝取並採少量多餐，應避免攝取全脂奶粉、奶油、冰淇淋、乳酪等高脂肪食物。烹調方式宜採用烘烤、燉煮、清蒸，少用油炸為佳。

3. 非手術取出膽結石療法：

(1)內視鏡括約肌切開術(endoscopic sphincterotomy；EST)：藉由內視鏡導入十二指腸，放入電熱刀將歐狄氏括約肌切開，然後放入氣球導管或籃狀導管將總膽管內的結石取出。

(2) 局部溶石療法：經內視鏡逆行性膽胰攝影(ERCP)將 MTBE(methyl tertiary

主題名稱	膽結石	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D03	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/10

butyl ether)灌入膽囊，以溶解膽固醇結石。MTBE 之毒性大，不能用於總膽管結石，最適合膽結石大於 2 公分不能口服 UDCA 者。

(3)內視鏡鼻導管引流術(ENBD)：利用十二指腸鏡將引流管之尖端經十二指腸乳頭置入膽管中，並越過結石，另一端由鼻孔穿出，將感染的膽汁引流出體外。

(4)體內碎石術(intracorporeal lithotripsy)：經由內視鏡導入電擊器以產生電波或雷射，將膽囊或總膽管內的結石擊成碎片，再藉由沖洗法或吸出術將結石碎片沖出體外。

4. 手術種類：

(1)膽囊造瘻術(cholecystostomy)：將膽囊切一開口以引流膽結石。

(2)總膽管切開術(choledochotomy)：將總膽管行一切口以取出結石，術後需置放 T 型管，預防膽管狹窄及引流膽汁。

(3)總膽管十二指腸造瘻吻合術(choledochoduodenostomy)：將總膽管和十二指腸吻合，以消除總膽管末端的阻塞。

(4)膽囊胃造瘻吻合術(cholecystogastrostomy)：將胃及膽囊行吻合術。

(5)總膽管取石術(choledocholithotomy)：切開總膽管以取出結石。

(6)膽囊切除術(cholecystectomy)：將膽囊切除並放置 T 型管，以維持總膽管通暢和引流膽汁。

(7)腹腔鏡膽囊切除術(laparoscopic cholecystectomy)：手術時間短、疼痛較輕、傷口較小、恢復期及住院日數較短的替代傳統膽囊切除術的治療方式。

A. 禁忌症：有敗血性腹膜炎、膽道或膽囊和腸道形成瘻管、嚴重血液及心肺疾病、懷孕第一及第二期、急性膽囊炎、先前曾接受過腹部大手術造成腹部沾黏、肝硬化、腹部惡性病變等，則不建議接受腹腔鏡膽囊切除術治療。

B. 後遺症：僅有部分病人會出現噁心症狀。在身體復原過程中，病人必須在手術後第一週食用低脂肪食物，且在一週之內病人也應請醫師作一次複檢，病人感到舒適時，即可恢復所有正常活動。

主題名稱	膽結石	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D03	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/10

(六) 護理問題

- 1.疼痛不適／疾病。
- 2.易感染／侵入性醫療程序及手術傷口有關。
- 3.缺乏營養／疾病。
- 4.尋求（特定的）健康協助／與缺乏接觸正確訊息之機會有關。

(七) 護理措施

1. 疼痛不適／疾病

- (1) 評估疼痛位置、嚴重程度、頻率、持續時間、促進與緩解因素。
- (2) 依醫囑給予 Demerol 止痛劑，並評估使用後效果。
- (3) 避免使用 Morphine，因 Morphine 會增加膽道括約肌的痙攣及壓力。
- (4) 協助每 2 小時更換姿勢並給予背部按摩。
- (5) 依醫囑注射 Meperidine，probanthine 以減輕痛性痙攣和手術傷口引起的疼痛。
- (6) 維持安靜環境臥床休息，協助安排舒適臥位，如採低坐臥位（將床頭抬高 30~45 度），並避免彎曲膝蓋以降低對右上象限區的壓迫。
- (7) 避免攝取高脂肪和粗糙、纖維性食物，以免產生痛性痙攣。

2. 易感染/侵入性醫療程序及手術傷口有關。

- (1) 將 T 型管固定於腹部皮膚上，並每 8 小時觀察導管是否脫落或重新固定。
- (2) 監測和紀錄 T 型引流管引流液的顏色、量、性質、味道，正常時引流液會越來越少，且顏色會由紅色→咖啡色→墨綠色。若引流量變多且顏色變為紅色，則需立刻通知醫護人員。
- (3) 密切觀察是否出現腹脹、腹部僵硬、噁心、嘔吐等腹膜受感染的徵象，若出現上述現象，表示膽汁滲漏至腹腔，需立刻告知醫護人員。
- (4) 需確實將引流袋置於傷口下方，於躺下時採半坐臥式，以預防引流液逆流造成感染。
- (5) 監測是否再度發生膽管阻塞的症狀，如黃疸、灰色便等。

主題名稱	膽結石	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D03	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/10

3. 缺乏營養／疾病

- (1) 監測輸出輸入量。
- (2) 予衛教採低脂肪、高碳水化合物與蛋白質之飲食。
- (3) 依醫囑給予靜脈輸液。
- (4) 因為膽道功能尚未完全恢復，無法分泌充分的膽汁進入腸道乳化脂肪，故予衛教在術後 4-6 週內最好限制脂肪類食物的攝取。

4. 尋求（特定的）健康協助／與缺乏接觸正確訊息之機會有關

- (1) 教導認識膽道再度阻塞的徵象：尿液顏色變深、皮膚搔癢、黃疸、灰色便等，若出現上述徵象，需立刻就醫。
- (2) 一般膽道手術的病人於恢復期鼻胃管、引流管會給予移除，若身上帶著 T 型管出院時，需教導傷口及導管周圍皮膚護理及更換敷料技術，並告知傷口感染徵象，如持續性發紅、疼痛、膿性引流液、腫脹、發燒，若出現上述現象需立刻就醫。
- (3) 予飲食衛教，禁菸酒及攝取低脂肪飲食和少量多餐進食方式，減少高膽固醇食物的攝取，如肥肉、豬油、牛油、蛋黃、蝦蟹、動物內臟（腦、腎、心、肝）、牡蠣、魚卵、奶油、蛋糕、全脂牛奶及油炸類食物，以減少再發生的機會，多吃魚、肉，因含豐富 EPA 脂肪酸，可降低中性脂肪及血中膽固醇。
- (4) 手術後 4-6 週，需避免舉重物（二公斤以上）和過度疲勞。
- (5) 避免用餐間隔過久，因飽食超過 12 小時，膽汁成分逐漸變成易孳生結石狀態。
- (6) 儘可能保持傷口的清潔與乾燥，以避免傷口感染，必要時可以優碘棉棒進行消毒。
- (7) 術後會有輕微腹瀉現象，不必過於擔心，症狀會逐漸改善痊癒。

（八）衛教指導

1. 留置 T 型管之居家護理

主題名稱	膽結石	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D03	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/10

- (1)穿著寬鬆衣服。
- (2)避免盆浴，使用擦拭。
- (3)避免提重物及劇烈活動。
- (4)保持傷口乾燥，並觀察傷口引流管周圍的皮膚狀況，並以膠布固定好於皮膚上。
- (5)每天於固定時間將引流液清除，觀察顏色、量、性質等，維持整個引流系統的清潔。
- (6)如出現異常的顏色（如白色等）、量、味道及疼痛、噁心、嘔吐等不適需立即就醫。
- (7)活動時需將引流管置於傷口下方，並注意勿拉扯或扭曲管路。
- (8)觀察感染的徵兆及傷口顏色，有無紅、腫、熱、痛及發燒的情形。
- (9)定期回診追蹤。

（九）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一） 林貴滿(2023)．消化系統疾病病人之護理．內外科護理學（七版，第 10 章）．台北：華杏。
- （二） 李薇莉(2024)．消化系統疾病之護理．成人內外科護理（九版，下冊 16 章）．台北：華杏。

主題名稱	膽結石	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D03	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	8/10

(三) 馮容芬、郭淑芬、林小玲(2022)・消化系統疾病與護理・新編內外科護理學
(七版，12 章)・台北：永大。

七、附件

(略)

主題名稱	膽結石	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D03	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	9/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.11.30	1.0	新制定	97 年 11 月 30 日 護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改常見檢查內容的修辭	100 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	1.說明部份修辭 2.醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.04.07	3.1	1. 第三項第(一)、(二)目內容增修說明 2. 更新第六項參考資料	104 年 04 月 07 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.2	新增參考文獻於內文中	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第七目新增參考資料。 3. 第六項第二目參考資料修訂。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.4	第三項第九日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.08.05	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	膽結石	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D03	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	10/10

修正日期	版本	修正說明	備註
111.09.06	3.5	1. 第三項第二、五、八目內容增修。 2. 更新第三項第六、七目護理問題。 3. 第六項增加參考資料。 4. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	3.6	第三項第六目之 4、第七目之 4.護理問題修正。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.09.03	3.7	刪除第六項參考資料年限較久參考文獻。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過； 113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	3.8	第六項參考資料內容更新。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。